Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Portão

Rua Cuiabá, 145 - Bairro: Centro - CEP: 93180000 - Fone: (51)3098--5789 - Email: frportao1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002474-48.2022.8.21.0155/RS

AUTOR: JANAINA VALADA DA SILVA

RÉU: DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

JANAINA VALADA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de **DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA**. Narrou, em síntese, ser beneficiária de plano de assistência à saúde operado pela demandada e estar na oitava semana de gestação. Descobriu, entretanto, ser portadora de Trombofilia, necessitando do medicamento Enoxoparina 40mg para tratamento da doença. Referiu ter entrado em contato com a requerida, para que custeasse o medicamento, tendo esta negado o pedido, sob a justificativa de que a medicação era excluída do contrato. Aduziu ter sido abusiva a negativa, acrescentando ser remédio de custo elevado que não teria condições de pagar. Diante disso, requereu, em fase liminar, fosse a requerida compelida a custear todo o tratamento com a medicação Enoxoparina 40mg durante toda a gestação e 6 semanas após o parto e, ao final, postulou a procedência dos pedidos, a fim de que fosse confirmada a tutela provisória e condenada a requerida ao fornecimento do fármaco Enoxoparina 40mg pelo período necessário.

Indeferida a liminar (ev. 14).

Citada, **DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA** apresentou contestação ao evento 23. Alegou que o fornecimento do medicamento pleiteado não fazia parte das coberturas obrigatórias contratuais, conforme rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, atualmente considerado taxativo pela jurisprudência. Mencionou ter instaurado junta médica, cuja necessidade decorre da ANS sempre que ocorrerem divergências do ponto de vista técnico, a qual a autora e nem seu médico compareceram. Afirmou ter seguido o disposto na Lei 9.656/98 e nas regulações da ANS sobre o caso (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)). Por ter adotado as medidas que lhe eram cabíveis para agilizar e garantir os interesses da autora, realizando a auditoria médica, porque o medicamento não estava no rol da ANS e não se tratava de fármaco de uso domiciliar, sustentou não caber o custeio à operadora ré. Assim, requereu a improcedência do pedido.

Houve réplica (ev. 27).

Intimadas para provas (ev. 28), a demandada nada requereu (ev. 33) e a autora não se manifestou (ev. 35).

O Ministério Público exarou parecer opinando pela improcedência (ev. 38).

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Estão presentes as denominadas condições da ação, bem como os pressupostos necessários à constituição válida e regular do processo, motivo pelo qual inexiste óbice à apreciação do mérito.

Ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor nos termos do enunciado n° 469 do STJ que assim disciplina:

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.*

A controvérsia se restringe à existência de obrigação da operadora de saúde em fornecer a medicação Enoxoparina 40mg à autora, por não fazer parte das coberturas obrigatórias contratuais, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS.

Após o indeferimento da tutela provisória (ev. 14), a autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi distribuído sob o n° 5153719-38.2022.8.21.7000 e julgado pela 6ª Câmara Cível do TJ/RS, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo (processo 5153719-38.2022.8.21.7000/TJRS, evento 4, DESPADEC1) e negou provimento ao agravo de instrumento (processo 5153719-38.2022.8.21.7000/TJRS, evento 17, RELVOTO1).

Apesar de não se tratar de precedente qualificado, mas por a controvérsia travada nestes autos ter sido bem elucidada, para evitar enfadonha tautologia, peço vênia para transcrever o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator Niwton Carpes da Silva no agravo de instrumento n° 5153719-38.2022.8.21.7000, o qual adoto como razões de decidir:

> *Eminentes colegas. Trata-se, consoante sumário relatório, de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela postulada através da qual pretendia a cobertura do medicamento denominado ENXOPARINA.*

A decisão fustigada é do seguinte teor, sic:

> *Vistos.*
>
> *Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizado por JANAINA VALADA DA SILVA em face de DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA. Aduz a autora, em síntese, estar na oitava semana de gestação e ser portadora de Trombofilia, necessitando do medicamento Enoxoparina 40mg para tratamento da doença. Refere que entrou em contato com a requerida para que custeasse o medicamento, tendo o pedido negado, conforme justificativa de evento 1, DOC9. Pugna seja determinado, em sede de tutela antecipada, que a demandada garanta o custeio do tratamento durante toda a gestação e seis semanas após o parto.*
>
> *É o breve relato.*
>
> *Decido.*
>
> *Para a concessão da antecipação de tutela, é imperiosa a presença da probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).*
>
> *No caso concreto, provou a autora a necessidade da utilização do medicamento 'Clexane 40mg' (evento 1, DOC10), bem como a negativa de cobertura por parte da requerida, ao argumento de que se trata de medicamento que não integra as coberturas obrigatórias contratuais da ANS.*
>
> *Posteriormente, foi juntado o contrato firmado entre as partes, onde não consta expressamente fixado o fornecimento do medicamento em análise.*
>
> *Dessa forma, é aplicável ao caso concreto o art. 10 da Lei n° 9.656/98, que dispõe que os planos de saúde não possuem a obrigação de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar. O que, aliás, foi alterado com a edição da Lei n° 12.888/2013, que, tão somente, incluiu no plano-referência mínimo o fornecimento de medicamentos antineoplásicos e os radioterápicos e hemoterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, conforme a exceção do art. 12, I, c, e II, g, da referida legislação.*
>
> *E considerando que o medicamento de que necessita a autora não se enquadra na exceção legal impositiva de plano-referência mínimo, não é possível exigir que a demandada, por força do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, forneça o medicamento de que ela necessita.*
>
> *Nesse sentido:*
>
> *(...)*
>
> *Sendo assim, INDEFIRO a LIMINAR.*
>
> *Cite-se o(a) demandado(a) para contestar, querendo, no prazo de 15 dias.*
>
> *Com a contestação, intime-se o autor para réplica.*
>
> *Por conseguinte, especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, quais as provas que efetivamente desejam produzir em audiência ou fora dela, detalhando de maneira pormenorizada, para se saber da conveniência ou não, qual a finalidade de cada uma delas, inclusive e especialmente a pericial.*
>
> *Decorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista ao Ministério Público e venham os autos conclusos para sentença, a fim de que seja julgado o feito no estado em que se encontra.*

*No caso telado, vislumbra-se que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com o intuito de ver a recorrente compelida ao custeio do medicamento Enoxaparina 40mg, em razão de ser portadora de Trombofilia, cuja cobertura foi negada por não haver previsão do medicamento no Rol da ANS, por ser medicamento **off label** e por não haver obrigatoriedade de cobertura para uso do medicamento em ambiente domiciliar.*

*Foi negado o efeito suspensivo ativo postulado, porquanto o tratamento é para uso domiciliar, não se enquadrando nas exceções legalmente previstas, visto que não se trata de medicação antineoplásica, tampouco se trata de medicação utilizada em tratamento em **Home Care** (medicação assistida) como extensão hospitalar.*

*Nesse sentido, seguem precedentes do egrégio STJ, **sic**:*

> *RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).*
> *1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).*
> *2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.*
> ***3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).***
> *4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.*
> *5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.*
> *Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.*
> *6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.*
> *7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política*

Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido.
(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PORTADORA DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. FORNECIMENTO DE 'APARELHO CPAP' PARA USO CONTÍNUO E EXTRA-HOSPITALAR. CUSTEIO DO APARELHO PELO PLANO. NATUREZA ACESSÓRIA. USO AUTÔNOMO, FORA DE SITUAÇÃO DE INTERNAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. ***EXCEÇÃO LIMITADA À SITUAÇÃO DE HOME CARE OU PARA MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSTICOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEI N° 9.656/98.*** *DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL E ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NÃO VERIFICADA. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO.*
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1279431/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS.
OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO.
1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial.
2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática.
3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei nº 9.656/1998).
4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art.
5º, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada.
5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei nº 9.656/1998).
6. Nos termos da RN nº 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.
7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde).
Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei nº 6.360/1976 e 10, IV, da Lei nº 6.437/1977).
8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde.
9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e 6º, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN nº 338/2013 da ANS).
Precedentes.
10. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Ademais, o STJ, ao reconhecer a taxatividade do Rol da ANS, estabeleceu parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos cubram procedimentos não previstos no Rol, firmando as seguintes teses, ***in verbis:***

1) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3) É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso dos autos, incontroverso que o medicamento não consta no Rol da ANS, em razão disso foi realizada consulta ao site da CONITEC (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/fichas-tecnicas/enoxaparina_tvp_27mai2016.pdf/view), atualizado em 24/06/2022, onde foi constatado que não há avaliação para indicação clínica do medicamento Enxoparina, conforme segue, ***sic:***

> *MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO) Enoxaparina sódica ..... MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO Clexane® – solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/ 0,4ml(caixa com 2 e 10 seringas); 60mg/0,6ml; 80mg/0,8ml e 100mg/ml (caixa com 2 seringas) Versa® - solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/0,4ml (caixa com 2 e 10 seringas); 60mg/0,6ml e 80mg/0,8ml caixa com 2 seringas) Enoxalow® - solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/ 0,4ml; 60mg/0,6ml; 80mg/0,8ml e 100mg/ml (caixa com 1 e 10 seringas) Heptron® - solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/0,4ml 60mg/ml 80mg/0,8ml e 100mg/ml caixa com 2 e 10 seringas) Endocris® - solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/0,4ml(caixa com 10 seringas); 60mg/0,6ml e 80mg/0,8ml(caixa com 2 seringas). Cutenox® - solução injetável de 20mg/0,2ml; 40mg/0,4ml(caixa com 10 seringas); 60mg/0,6ml 80 mg/0,8ml (caixa com 2 seringas) . ..... POSSUI GENÉRICO ☐sim ☒não .....*
>
> *RECOMENDAÇÃO DA CONITEC ☒não avaliado * ☐em análise ☐ incorporar ☐ não incorporar ☐ exclusão *Até a presente data, não foi protocolada na CONITEC demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma indicação clínica, nem do laboratório fabricante, nem de qualquer outro demandante. Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde, sociedade de especialidade ou a empresa produtora do medicamento/equipamento, pode solicitar a avaliação da incorporação de tecnologias à CONITEC, desde que cumpra as exigências legais. .....*

Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto, ***voto por negar provimento ao agravo de instrumento,*** *mantendo a r. decisão recorrida.*

A motivação *per relationem* é admitida em nosso ordenamento jurídico, inclusive de forma expressa pelo legislador *(se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão - art. 46, Lei n° 9.099/95)* e também pela jurisprudência do STF e do STJ, desde que *"a) não tenha havido suscitação de fato ou argumento novo, b) a peça processual à qual se reporta a decisão esteja substancialmente fundamentada (...) c) a peça que contém a fundamentação referida esteja nos autos e que a ela as partes possam ter acesso"*[1].

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.*
> *(RE 730208 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 21-06-2013 PUBLIC 24-06-2013)*

E o Superior Tribunal de Justiça:

> *PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.*
> *1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.*
> *2. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a adoção, pelo julgador, de motivação exarada em outra peça processual juntada aos autos como fundamento da decisão (per relationem), desde que haja sua transcrição no acórdão.*
> *3. Recurso Especial não provido.*
> *(REsp n. 1.314.518/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 17/5/2013.)*

Como a autora não trouxe argumentos novos capazes de infirmar as razões de indeferimento lançadas no agravo de instrumento, decisão substancialmente fundamentada, e por ter sido transcrita acima, possível a utilização dessa forma de fundamentação.

Assim, a improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado por **JANAINA VALADA DA SILVA** em face de **DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA**.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigidos pelo IGP-M, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, tendo em vista a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido de serviço, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

À contadoria para cálculo das custas processuais. Após, intime-se a autora para pagamento no prazo de 15 dias. Inadimplidas, oficie-se ao Departamento de Cobrança.

Diante da contemporânea sistemática trazida pelo Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, insculpida no artigo 1010, §3º, do Código de Processo Civil, na eventualidade de interposição de recurso de apelação, proceda o Cartório na intimação da parte apelada, para que apresente contrarrazões, se assim entender, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitada em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA LIMA ZANINI, Juiz de Direito**, em 21/6/2023, às 5:29:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10040168862v21** e o código CRC **309bb680**.

1. DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10ª. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 343. ↩